

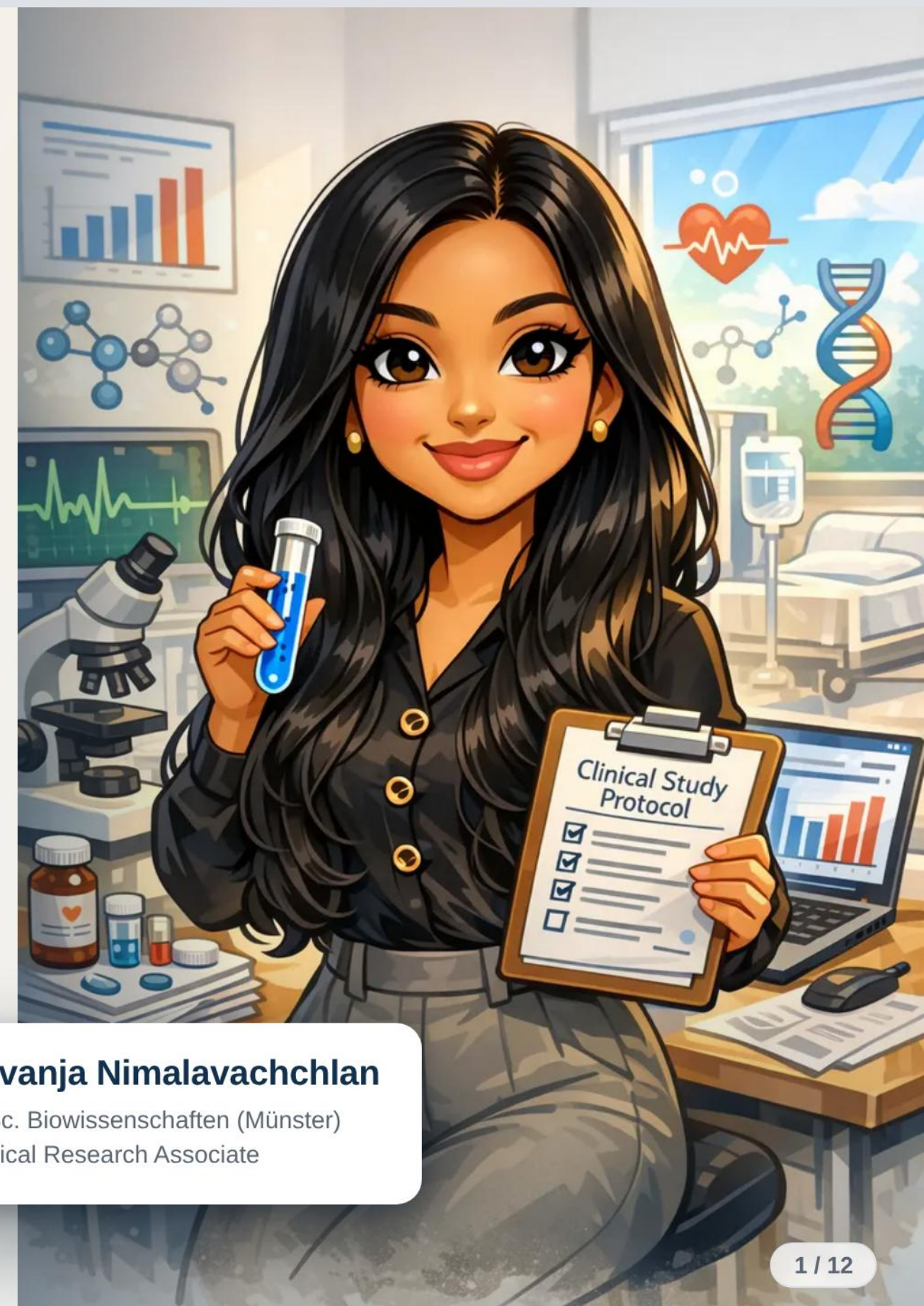
BERUFSPERSPEKTIVEN NACH DEM M.SC. BIOWISSENSCHAFTEN

Zwischen Labor und Management.

Was ein Clinical Research Associate macht —
und wie ich dahin gekommen bin.

Lavanja Nimalavachchlan

M.Sc. Biowissenschaften (Münster)
Clinical Research Associate



Wo ich gerade stehe.

Seit gut drei Jahren Clinical Research Associate — im Juni habe ich gewechselt.

04/2023 – 06/2026 · ERSTE STELLE

Monasterium Laboratory

Qima Life Science, Münster · Haut- und Haarforschung, **präklinisch**

- **Prälinik:** Forschung an humanem Gewebe
- Gewebespenden über Kliniken und Praxen organisiert — Einwilligungen, Ethikanträge, Biobank
- Das Kooperationsnetzwerk aufgebaut und gepflegt



SEIT 06/2026

Roche Diagnostics

über **Proclinical** · klinische Studien, Onkologie

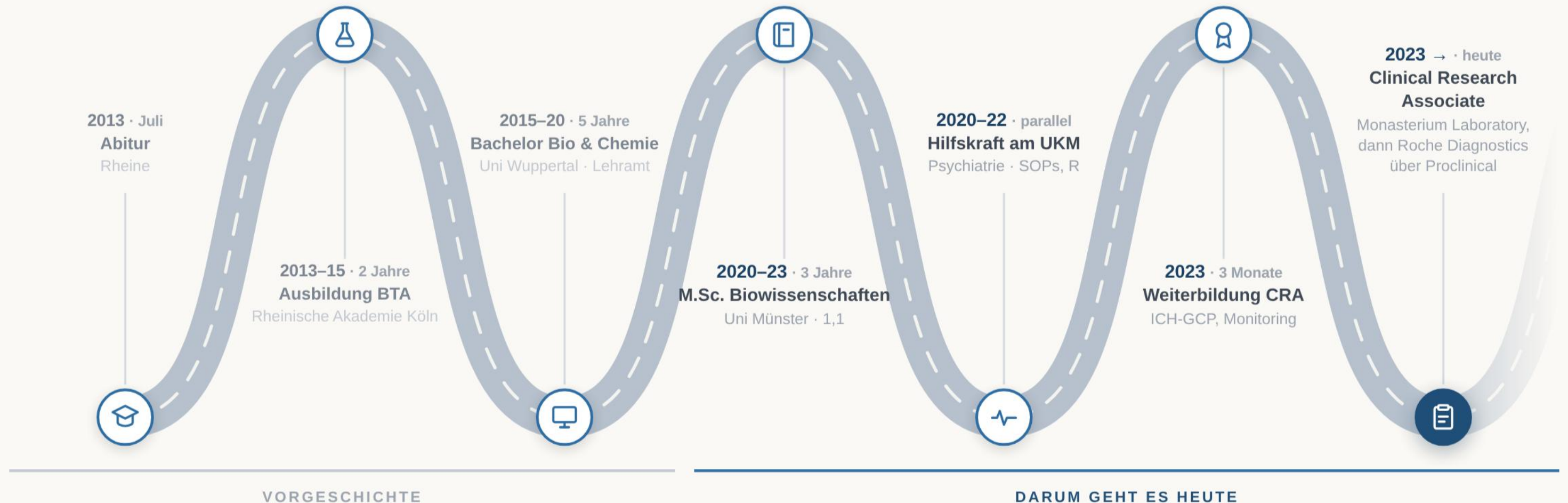
- **Companion Diagnostics:** Tests, die vorher zeigen, wer von einer Therapie überhaupt profitiert
- Studien, die darüber entscheiden, welche Patient:innen eine Behandlung bekommen — und welche nicht
- Internationales Umfeld, mehrere Länder

Zweimal derselbe Beruf — und zwei völlig verschiedene Welten.

Prälinik oder klinische Studie, Forschungsinstitut oder Konzern: Der Titel bleibt gleich, der Alltag ändert sich komplett.

Zehn Jahre in einer Minute.

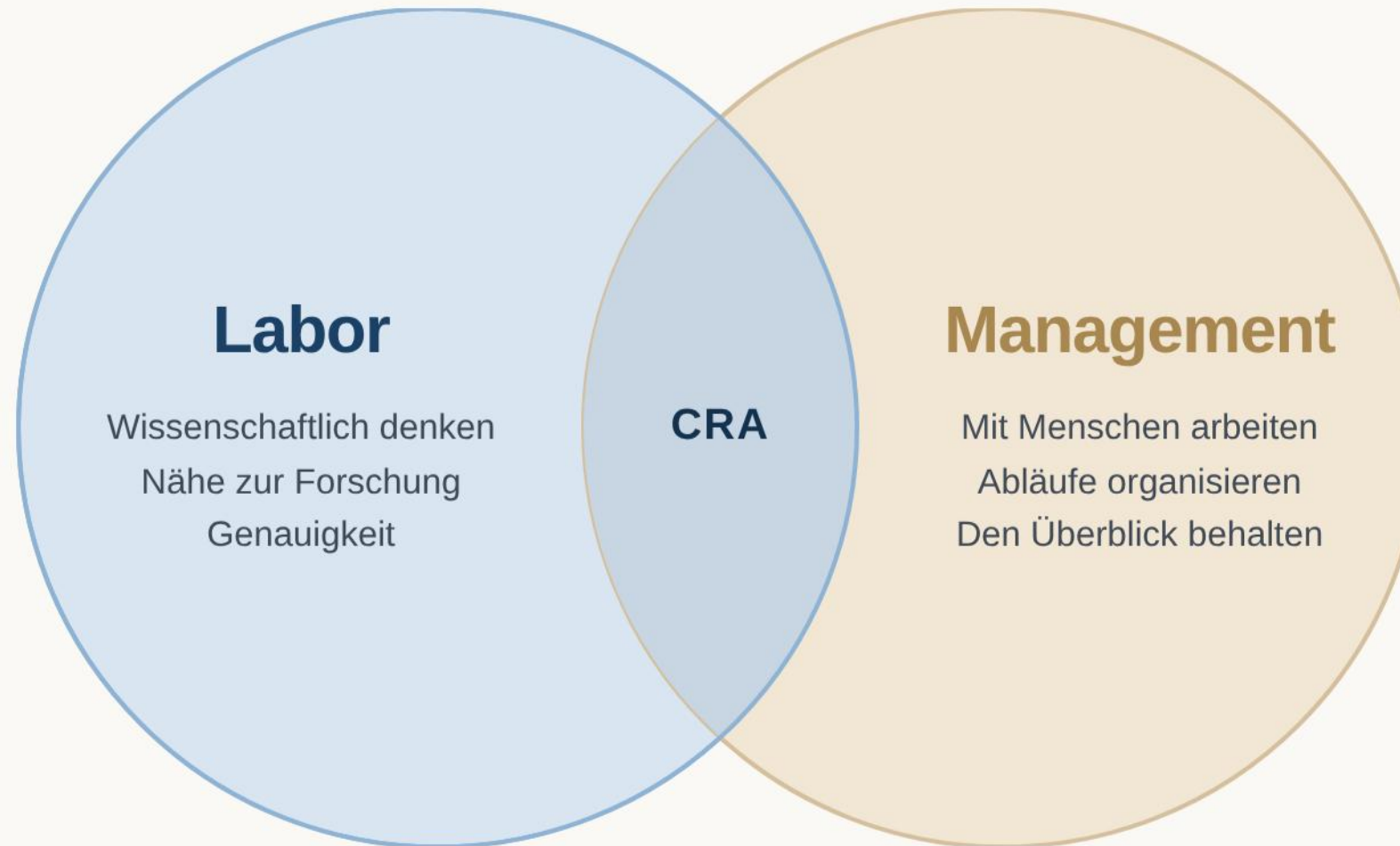
Mein Plan mit 19: Abi → Bachelor → Master → Promotion → Forschung. **Und dann kam das hier:**



Der Weg war nicht geradlinig — und das muss er auch nicht sein.

Jede Station hat etwas beigetragen, das ich heute brauche. Auch die, die sich damals wie ein Umweg angefühlt haben.

Labor oder Management? Ich wollte von beidem etwas.



DIE SCHNITTMENGE

Clinical Research Associate

Wissenschaftlich genug, um Protokolle und Daten wirklich zu verstehen — organisatorisch genug, um Zentren, Menschen und Timelines zu steuern.

Wie kommt man ohne Berufserfahrung rein?

Jede Stelle wollte 1–2 Jahre Erfahrung in klinischen Studien. **Mein Ausweg war eine Weiterbildung.**

Was man dort lernt

- ✓ ICH-GCP
- ✓ Monitoring klinischer Studien
- ✓ Medizinische Grundlagen
- ✓ AMG / MPDG
- ✓ Medical English
- ✓ Kommunikation mit Prüfzentren

Wo man sie findet

- **PharmaSchule** · **Pharmaakademie** · weitere private Bildungsträger
- IHK-Zertifikatslehrgänge, universitäre Zertifikatskurse
- Online-Anbieter, auch berufsbegleitend neben einem Job

Sucht nach: „CRA Weiterbildung“ · „Clinical Monitoring Zertifikat“

DAUER

Bei mir 3 Monate Vollzeit — je nach Format auch Wochen oder berufsbegleitend

KOSTEN

Je nach Anbieter sehr unterschiedlich — meine lag bei **4.000 €**, selbst bezahlt

FÖRDERUNG

Bildungsgutschein möglich, aber nur mit **Arbeitslosmeldung** — vorher klären!

Weiterbildungen sind meiner Meinung nach unterschätzt.

Ein Zertifikat ersetzt keinen Abschluss — aber es öffnet eine Tür, die sonst zu bleibt. Bei mir kam die erste CRA-Stelle direkt im Anschluss.

Clinical Research Associate — oder: der Monitor.

Ich Sorge dafür, dass eine klinische Studie genau so läuft, wie sie im Protokoll steht — für die **Sicherheit der Patient:innen** und die **Qualität der Daten**.

WO ICH SITZE IM SYSTEM



Wo man angestellt sein kann

- **CRO** — Auftragsforschungsinstitut wie IQVIA, ICON, Parexel oder Fortrea. Der häufigste Einstieg.
- **Direkt beim Sponsor** — Pharma, Biotech, Medizintechnik
- **Forschungsinstitute** und Universitätskliniken
- Über einen **Personaldienstleister** — so bin ich bei Roche

Wie der Arbeitsalltag aussehen kann

- Viele Arbeitgeber setzen auf **Homeoffice** — man betreut die Prüfzentren im eigenen Radius
- **Reisen gehört dazu**: regional, deutschlandweit, teils international
- Wie viel genau, hängt stark von Arbeitgeber und Studie ab
- **Flexibilität** und Selbstorganisation sind Voraussetzung

Wofür ich verantwortlich bin.

Sechs Bereiche — wie ein Tag konkret abläuft, kommt gleich danach.

01 · AUSWÄHLEN

Wo eine Studie stattfindet

Passt die Klinik zur Studie? Ich entscheide mit, welche Zentren überhaupt teilnehmen — und bringe sie an den Start.

02 · PRÜFEN

Dass Protokoll und Wirklichkeit übereinstimmen

Was im Studienplan steht, muss in der Klinik auch so passieren. Das kontrolliere ich vor Ort.

03 · SCHÜTZEN

Die Sicherheit der Patient:innen

Wurde jemand nach Protokoll behandelt, sind Nebenwirkungen gemeldet? Wenn etwas abweicht, muss es auffallen — und zwar bei mir.

04 · SICHERN

Dass die Daten belastbar sind

Am Ende entscheidet ein Zulassungsantrag über diese Zahlen. Jede einzelne muss belegbar sein — auch noch Jahre später.

05 · BETREUEN

Dass das Zentrum arbeiten kann

Ich bin erste Ansprechpartnerin für Ärzt:innen und Study Nurses — und diejenige, die fragt, warum die Rekrutierung stockt.

06 · DOKUMENTIEREN

Dass alles nachvollziehbar bleibt

Berichte, Studienordner, Behördenunterlagen. Der Grundsatz der Branche: Was nicht dokumentiert ist, hat nicht stattgefunden.

 Und das alles gleichzeitig — für mehrere Zentren und meistens mehrere Studien parallel.

Zwei typische Tage — und sie sehen sehr verschieden aus.

A · TAG IM HOMEOFFICE

09:30 **Start: Mails und Priorisierung**

Welches Zentrum brennt heute?

10:15 **Bericht zur letzten Visite schreiben**

Deadline wenige Arbeitstage — nicht verhandelbar

11:30 **Call mit der Study Nurse**

Warum stockt die Rekrutierung?

14:00 **Sicherheitsmeldungen, Ethik- und Behördenunterlagen**

17:00 **Call mit den Kolleg:innen in den USA**

Zeitverschiebung — internationale Studien heißt späte Termine

B · TAG UNTERWEGS IM PRÜFZENTRUM

06:15 **Anreise — Zug oder Auto**

Unterwegs schon der Visitenplan

09:30 **Einwilligungen prüfen**

Jede Unterschrift, jedes Datum

10:30 **Daten gegen die Patientenakte abgleichen**

15:45 **Abschlussgespräch mit dem Prüfarzt**

Findings — freundlich, aber klar

18:30 **Rückreise oder Hotel**

Notizen tippen, solange alles frisch ist

Die Sache mit dem Reisen.

Der Punkt, der über Job und Lebensplanung entscheidet — **und den ihr im Bewerbungsgespräch ansprechen solltet.**

Wie viel wird gereist?

- Bei vielen Stellen **50–60 %** — etwa drei Tage pro Woche
- Es geht auch anders: meine Stelle liegt bei **1–2 Reisen im Monat**
- Hängt von Arbeitgeber, Studie und Anzahl der Zentren ab
- Ziele: meist regional, oft deutschlandweit, teils international

Wie ist das organisiert?

- **Reisezeit zählt als Arbeitszeit**
- Bahncard oder Flüge werden gestellt
- Hotelübernachtungen gehören dazu
- Im Zug wird meist schon gearbeitet — Bericht vorbereiten, Mails
- Die Termine plant man selbst — viel Freiheit, viel Eigenverantwortung

Was anstrengend ist

Jede Visite braucht Vor- und Nachbereitung. Wenn drei Termine in einer Woche liegen, wird es eng — **früh planen ist Pflicht**, sonst läuft man der Arbeit hinterher.

Der Rat, den ich euch mitgebe

Fragt im Bewerbungsgespräch konkret nach dem Reiseanteil. Das ist **keine unangenehme Frage** — und die Antwort entscheidet, ob der Job zu eurem Leben passt.

Passt das zu dir? Und wie kommt man überhaupt rein?

Passt gut, wenn du...

- ✓ Details liebst
- ✓ Abwechslung magst
- ✓ gern mit Menschen redest
- ✓ dich selbst organisieren kannst
- ✓ gern unterwegs bist

Passt eher nicht, wenn du...

- ✗ eigene Forschungsfragen stellen willst
- ✗ Bürokratie und Formulare hasst
- ✗ jeden Tag denselben Ablauf brauchst
- ✗ ungern Verantwortung trägst

Vier Wege in den Beruf

- Weiterbildung oder Zertifikat
- Clinical Trial Assistant (CTA)
- Study Nurse oder Studienkoordination
- In-House CRA bei einer CRO

Falls CRA nichts für dich ist — rund um klinische Forschung gibt es viele weitere Berufe:

Clinical Trial Manager

Regulatory Affairs

Pharmakovigilanz

Medical Writing

Clinical Data Management

Medical Science Liaison

Qualitätsmanagement

Application Specialist

Vier Dinge, die ich gern früher gewusst hätte.

01

Zwischen Labor und Management liegt sehr viel

Ich habe Jahre gebraucht, um zu merken, dass mein Wunschberuf überhaupt existiert. Sucht früher.

02

Der Doktor ist kein Muss

Fragt euch: Brauche ich ihn für den Job — oder für mein Selbstbild? Nur ehrlich muss die Antwort sein.

03

Der Weg ergibt nur rückwärts Sinn

Vorwärts fühlt sich jede Karriere nach Chaos an. Umwege sind keine Lücken, wenn ihr erzählen könnt, warum ihr sie gegangen seid.

04

Redet mit Leuten, die den Job machen

Eine Stellenanzeige sagt euch nichts über einen Beruf. Ein 20-Minuten-Gespräch schon. Also: fragt.

Und: pflegt euer LinkedIn-Profil



DANKE FÜRS ZUHÖREN

Fragen? Immer gern.

Wenn ihr über klinische Forschung, den Einstieg, die Promotionsfrage oder Weiterbildungen reden wollt — schreibt mir einfach. Ich hätte damals auch gern jemanden gefragt.

Lavanja Nimalavachchlan

Clinical Research Associate



[linkedin.com/in/lavanja-nimalavachchlan-102630200](https://www.linkedin.com/in/lavanja-nimalavachchlan-102630200)